

ITEM 307 : CANCER DE LA PROSTATE

- Cancer le plus fréquent chez l'homme > 50 ans (**50 000/an** = 1 Français/8), exceptionnel < 40 ans, âge moyen = 70 ans
- 3^{ème} cause de décès par cancer chez l'homme (**9000/an** : 10% des décès par cancer), 80% de survie à 5 ans
- FdR : **âge, afro-antillais, atcds familiaux** (2 parents de 1^{er} degré ou 1 parent de 1^{er} degré < 55 ans), **androgénotherapie**

Diagnostic	Dépistage	= Dépistage individuel après information objective : toucher rectal + dosage du PSA - Recommandé : > 45 ans si FdR, ou de 50 ans à 75 ans sinon, seulement en cas d'espérance de vie > 10 ans - Rythme de surveillance : tous les 2 ans si FdR, tous les 2 à 4 ans si PSA > 1 ou tous les 8 ans si PSA < 1		
	SF	- Généralement asymptomatique au stade localisé - Signes locorégionaux : troubles urinaires irritatifs ou obstructifs , hémospérmié , hématurie , AEG - MT osseuse : douleur osseuse, compression médullaire, tumeur ostéocondensante, hypo/hypercalcémie - ADP : thrombophlébite ou OMI asymétrique , dilatation urétéro-pyélocalicelle		
	SC	TR systématique (même si PSA normal) : nodule dur, irrégulier, non douloureux - Extension : envahissement des vésicules séminales, franchissement capsulaire, atteinte des 2 lobes		
	Bio	PSA total sérique	= Seuil < 4 ng/mL : sensibilité de 70% et spécificité de 90% → VPP = 30% et VNP = 90% - ♂ : HBP, prostatite, infection urinaire, sondage urinaire, rétention d'urine, âge, rapport sexuel, TR - Lié au volume de prostate : 50 à 60 ans = 3 ng/mL , 60-70 ans = 4 ng/mL , > 70 ans = 5 ng/mL - Densité du PSA : rapporté au volume prostatique (PSAd) ou de l'HBP (PSAdtz : 1 ng/ml pour 10 ml d'adénome) → améliore la valeur diagnostique dans la tranche de 2,5 à 10 ng/ml - Cinétique du PSA : une élévation rapidement progressive doit inciter une nouvelle cs en urologie - Cs urologie pour éventuelle biopsie prostatique si anormale sur 2 dosages à 1 mois d'intervalle	
		PSA libre/total	= Indiqué en 2 nd intention si PSA en ♂ entre 4 et 10 ng/mL après une 1 ^{ère} série de biopsies - Orientation diagnostique : - Si > 20% : en faveur d'une HBP - Si < 10% : en faveur d'un cancer de prostate ou d'une prostatite	
		Autres	- PCA3 (surexprimé par le cancer de la prostate) : rapport urinaire PCA3/PSA , non remboursé	
	Biopsie de prostate	- Permet le d'affirmer le diagnostic de cancer de la prostate si positif - Aggressivité : score de Gleason (différenciation), nombre de biopsies positives , longueur d'envahissement du cancer, infiltration ou envahissement de la capsule et des espaces péri-prostatique		
		Indication	- Suspicion de cancer sur le TR ou progression/élévation du taux de PSA	
		Réalisation	= ≥ 12 prélèvements (6/lobe), échoguidée, par voie transrectale, sous AL et antibioprophylaxie par fluoroquinolone, après lavement rectal la veille et ECBU stérile	
	Extension	Complication	- Prostatite aiguë (2%) : hospitalisation, traité par C3G sans fluoroquinolone - Rétention d'urine , douleur périnéale , malaise vagal , hypotension - Complication hémorragique : urétrorragie , rectorragie , hémospérmié , hématurie	
- IRM pelvienne multi-paramétrique : recommandé en cas de risque intermédiaire ou élevé → Possiblement avant biopsie en cas de suspicion de cancer de la prostate au TR ou sur une élévation du PSA - TDM thoraco-abdomino-pelvien : bilan d'extension si risque intermédiaire ou haut risque ou M+ - Scintigraphie osseuse : recherche de MT osseuse → recommandé en cas de risque intermédiaire ou haut risque - PET-scanner à la choline (en investigation) : récurrence ou localisation de métastase en cas de haut risque				
Classification	Histologie	- Adénocarcinome (90% des cas) : marquage p63-/PSA+, préférentiellement dans la partie périphérique - Autre (rare) : carcinome épidermoïde , carcinome neuroendocrine (évolution d'un ADK), sarcome , MT ...		
	Score de Gleason	= Score histo-pronostique : degré de différenciation de 1 à 5 → grade le plus élevé + grade le plus représenté sur la biopsie prostatique ou 2 grades les plus représentés sur la prostatectomie - Groupe : 1 = Gleason 6 2 = Gleason 3+4 3 = Gleason 4+3 4 = Gleason 8 5 = Gleason 9 ou 10 → Non réalisable après curiethérapie ou radiothérapie		
	TNM	- T1 = non palpable, non visible en imagerie : T1a/b = diagnostic sur RTUP (1a < 5% et Gleason 6, 1b > 5% ou Gleason 7), 1c = découverte par ♂ isolée du PSA - T2 = limité à la prostate (apex et capsule compris) : T2a = atteinte < moitié d'un lobe ; T2b = atteinte > moitié d'un lobe ; T2c = atteinte des 2 lobes - T3 : T3a = extension au-delà de la capsule ; T3b = vésicules séminales - T4 = organes adjacents (sphincter urétral, rectum, paroi pelvienne), tumeur fixée	N1 : ADP régionale N1mi : ADP < 0,2 cm M1 : MT à distance (ADP non régional, os ou autre site)	
	Score d'Amico	- Risque faible : PSA < 10 ng/mL et score de Gleason ≤ 6 et stade clinique ≤ T1c ou T2a - Intermédiaire : PSA = 10-20 ng/mL ou score de Gleason = 7 ou stade clinique = T2b - Risque élevé : PSA > 20 ng/mL ou score de Gleason ≥ 8 ou stade clinique ≥ T2c		

TTT	Surveillance active	- Surveillance : PSA et TR tous les 3 à 6 mois, IRM et biopsies à 1 an puis tous les 2-3 ans - Indication : bas risque avec 1 à 3 biopsies positives/≥ 10 prlvmts et longueur tumorale < 3 mm - Arrêt : - PSA > 10 ou doublement du PSA en < 3 ans - Apparition d'un Gleason > 7 - Stade clinique ≥ T2b au TR - Souhait du patient	
	Prostatectomie totale	= Exérèse complète de la prostate et des vésicules séminales avec anastomose vésico-urétrale ± Curage ilio-obturateur bilatéral si risque intermédiaire/élevé (optionnel si risque faible) - Indication : cancer localisé ou localement avancé, espérance de vie > 10 ans, âge < 75 ans - Possible seulement si stade ≤ T3a (sans atteinte des vésicules séminales) - Voie d'abord : ouverte rétropubienne, périnéale ou laparoscopique ± assistée par robot - Avec préservation des bandelettes nerveuses si faible risque de franchissement capsulaire - EI : dysfonction érectile, incontinence urinaire, infertilité, anéjaculation, sténose (rare)	
	Radiothérapie externe	= Irradiation guidée de la loge prostatique avec technique conformationnelle tridimensionnelle - EI : dysfonction érectile (↗ si hormonothérapie concomitante), rectite radique, cystite radique, sténose urétrale, tumeur radio-induite du rectum ou de la vessie (RR = 1,5) → Diminue fortement le risque d'incontinence urinaire par rapport à la prostatectomie - CI : antécédents d'irradiation pelvienne antérieure, maladie inflammatoire rectale active ± Hormonothérapie courte durée (6 mois) si risque intermédiaire ou longue durée (3 ans) si élevé	
	Curiethérapie	= Mise en place de radioéléments (I^{125}) par voie transpérinéale sous contrôle écho, sous AG - Indication : cancer localisé, faible risque d'Amico, espérance de vie > 10 ans - CI : volume prostatique > 50 mL, symptômes du bas appareil urinaires obstructifs (risque de rétention aiguë), cancer du lobe médian, atcd de résection endoscopique de prostate - EI : dysfonction érectile (avec un risque plus faible), rectite, incontinence urinaire (rare)	
	Autres traitements locaux	- Ultrasons focalisés (HIFU) sous AG avec résection prostatique : récurrence tumorale après radiothérapie, contre-indication à la radiothérapie ou refus de chirurgie d'un cancer localisé - Autre : cryothérapie (peu utilisé), photothérapie dynamique (en cours d'évaluation)	
	Suppression androgénique	= Suppression de l'effet des androgènes sur la prolifération des cellules tumorales prostatiques : - Cible de testostéronémie < 0,5 ng/ml - TTT palliatif : efficace pendant 3 ans en moyenne, suivi d'une phase de résistance à la castration	
		Chirurgical	- Pulpectomie bilatérale : définitive
		Antagoniste de la LHRH	= Dégarelix (Firmagon®) : injection SC 1/mois - Antagonisation rapide, sans effet <i>flare up</i>
		Agoniste LHRH	= Triptoréline (Decapeptyl®), leuproréline (Enantone®), gosoréline (Zoladex®) - Injection IM ou SC - Associé à anti-androgène de 10 jours avant à 1 mois après (↘ l'effet <i>flare up</i>)
		Anti-androgène	= Blocage direct des récepteurs : prise orale, jamais en monothérapie - Stéroïdien : acétate de cyprotérone (Androcur®) - Non stéroïdien : bicalutamide (Casoex®), flutamide (Eulexine®)
		EI précoces	- Bouffées de chaleur, baisse de libido, trouble érectile, asthénie
		EI tardifs	- Gynécomastie, ostéoporose, perte musculaire, dépression, FdRCV (diabète, dyslipidémie, HTA), prise de poids, cardiopathie, troubles neuropsychiques
		Phase de résistance à la castration	- Testostéronémie à des taux de castrations < 0,5 ng/mL - 3 augmentations de PSA > 50% du nadir à 2 semaines d'intervalle - Retrait de l'anti-androgène depuis > 4 à 6 semaines (non systématique) - Progression radiologique (progression clinique non suffisante)
	Autres hormones	= En phase de résistance à la castration si peu symptomatique : 2nd génération d'hormonothérapie - Acétate d'abiratérone (inhibiteur de synthèse des androgènes) associé à des corticoïdes - Enzalutamide (inhibiteur du récepteur des androgènes)	
	Chimiothérapie	- Indication : cancer de prostate métastatique résistant à la castration et symptomatique - Docétaxel (Taxotère®) + prednisone en 1^{ère} ligne, cabazitaxel (Jevtana®) en 2nd ligne	
	Soins palliatifs et soins de support	- Biphosphonate ou dénosumab (inhibiteur de RANK-ligand) = ↘ le risque d'événement osseux : à introduire dès la résistance à la castration ou en cas de métastase osseuse - Chirurgie de l'obstacle sous-vésical : forage prostatique par résection endo-urétrale - Chirurgie de l'obstruction rénale (si envahissement du trigone vésical avec dilatation pyélocalicielle) : néphrostomie - MT osseuse : antalgique (palier 1, 2 ou 3), radiothérapie antalgique, irradiation métabolique	

Stratégie thérapeutique	Bas risque	- Bilan d'extension : IRM optionnelle (souvent réalisée), scanner et scintigraphie non indiquée - Surveillance active (ou surveillance simple si espérance de vie < 10 ans) - Prostatectomie radicale sans curage obligatoire - Radiothérapie (76-78 Gy) - Curiethérapie	
	Risque intermédiaire ou élevé	- Bilan d'extension : IRM, scanner et scintigraphie osseuse obligatoires	
		Risque intermédiaire	- Prostatectomie radicale avec curage ganglionnaire étendu - Radiothérapie (> 76-78 Gy) - Radiothérapie + hormonothérapie courte (6 mois) : protocole Bolla - Traitement multimodal : chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie
		Haut risque	- Prostatectomie radicale avec curage ganglionnaire étendu : chez le sujet jeune, possible uniquement si stade ≤ T3a (vésicules séminales non atteintes) - Radiothérapie + hormonothérapie longue (3 ans)
	Cancer métastatique	- 1^{ère} intention : - Suppression androgénique : agoniste ou antagoniste LH-RH - Prise en charge palliative symptomatique : douleur osseuse, anémie, dysurie... - Phase de résistance : - Blocage complet possible : adjonction d'un anti-androgène (si non réalisé) - Si blocage complet : arrêt de l'anti-androgène pour tester le syndrome de retrait des androgènes → réponse (↘ PSA) dans > 30% des cas, sur 3-6 mois - Cancer résistant à la castration : - Autres hormonothérapies : enzalutamide, acétate d'abiratéran... - Chimiothérapie au docétaxel si patient symptomatique - Cancer résistant à la castration et à la chimiothérapie : association d'acétate d'abiratéran et de prednisone, d'enzalutamide ou nouvelle ligne de chimiothérapie (cabazitaxel)	
	Surveillance	= A vie (récidive, séquelle de traitement) : tous les 6 mois pendant 5 ans puis 1/an - PSA : - < 0,2 ng/mL à 1 mois après chirurgie - < PSA nadir + 2 ng/ml (valeur la plus basse) après radiothérapie ou curithérapie - < PSA nadir x 1,5 si hormonothérapie → Contrôlé à 3 mois en cas de suspicion de récurrence : bilan clinique et d'imagerie si confirmé - Testostéronémie totale si suppression androgénique : cible < 0,5 ng/mL	
	Génétique	- Forme héréditaire : - 3 cas de cancer de prostate chez des apparentés au 1^{er} ou 2^{ème} degré - 2 cas de cancer de prostate < 55 ans chez des apparentés au 1^{er} ou 2^{ème} degré - Consultation oncogénétique si : - Atcds familiaux de cancers du sein ou de l'ovaire - Cancer de prostate agressif < 50 ans	